急激な貧血の進行を認め Donath-Landsteiner 試験が陽性を示した PCH の一例

◎松尾 早也伽[1)]、杉浦 縁[1)]、三輪 美奈子[1)]、田中 葵彩[1)]
藤田学園 藤田医科大学ばんたね病院[1)]

【はじめに】発作性寒冷ヘモグロビン尿症（PCH）は、Donath-Landsteiner 抗体（DL 抗体）により血管内溶血を惹起する稀な自己免疫性溶血性貧血（AIHA）である。今回我々は、急性腎不全を合併するほどの急激な溶血を認め、早期の DL 試験実施により診断に至った貴重な症例を経験したので報告する。

【症例】50 代男性。既往歴特記事項なし。冬期に上気道炎発症後、ゴルフ、バイクによるツーリングと寒冷刺激を受け、その翌日倦怠感と褐色尿を自覚した。近医に受診し黄疸と肝酵素上昇を指摘され当院に紹介受診された。著明な貧血、肉眼的血尿、および生化学検査における LDH 上昇、間接ビリルビン優位の黄疸、ハプトグロビン低下、尿潜血陽性の所見から、溶血性貧血を強く疑い精査を施行した。直接抗グロブリン試験は、抗 IgG 弱陽性、抗補体 3＋、DL 試験陽性、寒冷凝集素価は 4 倍と正常範囲内であり、PNH（発作性夜間ヘモグロビン尿症）マーカー、マイコプラズマ抗体、その他ウイルス感染症は陰性であったことより PCH と診断された。網赤血球数は正常範囲内であり、末梢血液塗抹標本にて破砕赤血球(-)、球状赤血球がわずかに認められた。軽度の脾腫を認めたが胆石(-)であった。血液検査にて著明な溶血性貧血の所見（初診時 Hb 10.8 g/dL から 2 日後に 6.7 g/dL へ急落）と肉眼的血尿、急性腎不全を認め、一時的に血液透析が施行された。

【経過・結語】 本症例は副腎皮質ステロイド治療、輸血療法を要さず、保存的加療と透析により貧血・腎機能ともに改善し退院となった。退院発症 2 か月後の DL 試験は陰性化した。PCH の溶血は非常に急激かつ一過性であり、急性腎不全など重篤な合併症を伴う。病勢のピークを逃さずに早期から DL 試験を含む多角的な溶血精査を行うこと、また迅速に検査対応できる体制を維持することの重要性が示唆された。